PROTOCOLLO 101

Dimissione e prevenzione delle recidive

Concludere il percorso rendendo il paziente autonomo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Tutti i quadri	20 minuti	Ultima seduta

Indicazioni

- ✓ Obiettivi raggiunti
- ✓ Dolore stabile e gestibile
- ✓ Programma domiciliare consolidato

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Rivalutazione finale

Confronta le misure con quelle iniziali.



Programma di mantenimento

3 esercizi essenziali da continuare.



Piano di riacutizzazione

Consegna la scheda scritta.



Follow-up

Programma un controllo a 1 o 3 mesi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Mantenimento	5 minuti al giorno
Controllo	a 1 o 3 mesi
Documentazione	relazione finale

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Celebra i progressi con il paziente
- ✓ Lascia strumenti concreti
- ✓ Comunica l'esito ai colleghi coinvolti

Errori da evitare

- ! Dimissione senza programma
- ! Assenza di follow-up
- ! Non documentare i risultati

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Programma di mantenimento	I 3 esercizi scelti insieme	5 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Una dimissione ben strutturata riduce le recidive e rafforza la fiducia del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.